

Genou

Considérations générales

Ne pas commencer par la zone douloureuse

Toujours comparer les deux côtés

Ne pas mobiliser un genou traumatique

Les pathologies de la hanche peuvent se manifester par des douleurs au(x) genou(x)

Inspection

- Marche
- Valgus/varus,
- Flexum/recurvatum
- Déformation,
- État cutané (cicatrices, inflammation, plaie)
- Tuméfaction
- Amyotrophie

Palpation

- Chaleur, sensibilité grossière
- Tubérosité tibiale
- Ligament patellaire
- Patella + ses bords
- Ligament quadricipital
- Interligne articulaire int et ext (ménisque)
- LLI (épicondyle interne – en dessous de la patte d'oie)
- LLE (épicondyle externe – tête de la fibula)
- Creux poplité (kyste de Baker = signe d'hyperproduction de liquide synovial)

Mouvements

- Flexion/extension (Passif > Actif ; mais toujours faire l'extension en actif)

Tests fonctionnels

Patella :

- Test du glaçon
- Test d'appréhension = pousser la patella latéralement ; test de Smilie si peu claire = rajouter une flexion lors du test d'appréhension
- J-signe = Extension active → latéralisation de la patella en fin d'extension

LCA :

- Lachman, tester à 15-30°, astuce on peut poser le genou du patient sur le nôtre et l'y maintenir avec une main par-dessus, puis faire de petit à-coup derrière le tibia (ou aurait attrapé normalement), répété plusieurs fois
- Tiroir ant, tester à 90°

LCP :

- Tiroir post
- Inspection genou en l'air à 90°, pied posé sur la table → abaissement tibia côté lésé

LLI/LLE

- Abduction/adduction à 0° → pas/très peu de mobilité
- Abduction/adduction à 30° → légère mobilité

Ménisque

- Int : rotation ext du tibia + varus du genou (de flexion max en extension) → douleur ou ressaut
- Ext : Rotation int du tibia + valgus du genou (de flexion en extension)

Peut se faire à plat ventre = grind test (même logique pour le mouvement, RI ou RE)

Examen Hanche

- Flexion/extension (douleurs ?)
- Rotation int/ext (douleurs ?)